



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Saúde

Ofício SMS nº 14428/2026

Às Coordenadorias Gerais de Atenção Primária,
com vistas aos profissionais de Saúde da Atenção Primária

Rio de Janeiro, 28 de abril de 2026

Assunto: Nota técnica acerca do manejo das síndromes respiratórias agudas pelas equipes de atenção primária da cidade do Rio de Janeiro

A Superintendência de Atenção Primária em conjunto à Superintendência de Vigilância em Saúde publicam a Nota Técnica que dispõe sobre o manejo das síndromes respiratórias agudas pelas equipes de atenção primária da cidade do Rio de Janeiro.

Para ampla divulgação nas unidades de saúde da Atenção Primária à Saúde.

Anexos:

Nota Técnica Manejo de SRA pela APS da cidade Rio de Janeiro - 3593366

Anexo 1 - Fluxograma – criança de 0 a 5 anos na APS com quadro de tosse e/ou dificuldade respiratória - 3594101

Anexo 2 - Fluxograma – bronquiolite viral aguda na APS - 3594148

Anexo 3 - Fluxograma – manejo da asma ou sibilância em crianças menores de cinco anos - 3594184

Anexo 4 - Fluxograma – pneumonia adquirida na comunidade (PAC) - 3594236

Anexo 5 - Lista de contatos das Divisões de Vigilância em Saúde - Município do Rio de Janeiro - 3594594

Atenciosamente,

GISLANI MATEUS OLIVEIRA AGUILAR
Superintendente de Vigilância em Saúde
Matrícula: 2952687
S/SUBPAV/SVS

LARISSA CRISTINA TERREZO MACHADO
Superintendente de Atenção Primária
Matrícula: 3243623
S/SUBPAV/SAP



Documento assinado eletronicamente por **LARISSA CRISTINA TERREZO MACHADO**, Superintendente, em 28/04/2026, às 17:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 26 do [Decreto Rio nº 57.250, de 19 de novembro de 2025](#).



Documento assinado eletronicamente por **GISLANI MATEUS OLIVEIRA AGUILAR**, Superintendente, em 28/04/2026, às 17:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 26 do [Decreto Rio nº 57.250, de 19 de novembro de 2025](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://prefeitura.sei.rio/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0&cv=3590876&crc=84A59FF8, informando o código verificador **3590876** e o código CRC **84A59FF8**.

NOTA TÉCNICA: MANEJO DAS SÍNDROMES RESPIRATÓRIAS AGUDAS PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Atualizada em 28/04/2026.

1- INTRODUÇÃO

As infecções respiratórias agudas (IRA) são doenças que acometem qualquer segmento do trato respiratório e impõem um desafio significativo, sendo uma das principais causas de morbidade e mortalidade infantil. A maioria das crianças têm de 4 a 6 infecções por ano, e aproximadamente 2 a 3% evoluem para infecção do parênquima pulmonar. Historicamente, o foco do manejo limitava-se ao tratamento do episódio pontual. Contudo, cada vez mais se reconhece a importância de uma atuação integrada voltada à prevenção de desfechos adversos e internações, identificando precocemente sinais de alarme, garantindo acesso a imunizações e profilaxias específicas, tais como o Palivizumabe e o Nirsevimabe, a imunização materna contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), a vacinação contra a Influenza — ofertada no município a todas as pessoas a partir dos seis meses de idade. Além disso, acionar o sistema de Vaga Zero oportunamente. Os fatores de risco para desfechos desfavoráveis incluem idade precoce, comorbidades, prematuridade, ausência de aleitamento, vacinação incompleta e vulnerabilidade socioeconômica. O objetivo desta nota técnica, atualizada em 2026, é estruturar o manejo e a prevenção de riscos nas unidades de atenção primária, reduzindo os impactos da sazonalidade e protegendo essas populações vulneráveis (especialmente crianças e gestantes).

2- AGENTES ENVOLVIDOS

Múltiplos agentes virais estão envolvidos nos quadros respiratórios, com grande sobreposição clínica. O painel de monitoramento da Sala Zero da vigilância do Município do Rio de Janeiro (Março de 2026) detectou um aumento expressivo dos atendimentos por bronquiolite e pneumonia em crianças menores de 2 anos, atingindo o quantil 60 da série histórica. A co-circulação viral nas primeiras semanas epidemiológicas de 2026 demonstrou um franco predomínio de Rinovírus e elevação acentuada de Influenza A, seguidos pelo SARS-CoV-2, com início da ascensão outonal do Vírus Sincicial Respiratório (VSR). O cenário de epidemias concomitantes, incluindo o alerta para Chikungunya, exige que a rede assistencial amplie a sensibilidade para estratificação de risco imediata.

3- OS EPISÓDIOS DE CUIDADO DOS QUADROS RESPIRATÓRIOS AGUDOS EM CRIANÇAS COM ATÉ 5 ANOS DE IDADE

O acompanhamento dos quadros respiratórios agudos em crianças pode ser entendido a partir de uma perspectiva de episódio de cuidado, dividido nas seguintes etapas:

- a) Atendimento inicial, com estratificação de risco e manejo conforme o risco:
 - i) Recepção pelo ACS;
 - ii) Se sinais de alarme, avaliação dos sinais vitais pelo técnico de enfermagem, com aprazamento da avaliação médica e/ou de enfermagem;
 - iii) Avaliação médica e/ou de enfermagem;
 - iv) Estratificação de risco;
 - v) Classificação sindrômica;
 - vi) Manejo conforme protocolo;
 - vii) Se necessidade de vaga zero:
 - 1) Explicar sobre necessidade de avaliação em serviço de urgência;
 - 2) Solicitar vaga zero na plataforma;
 - 3) Manejo dos sinais de gravidade enquanto aguarda ambulância;
 - 4) Orientação de retorno após alta;
 - viii) Se seguimento ambulatorial: Explicação, planejamento e rede de segurança:
 - 1) Explicar o que o paciente tem e a evolução esperada;
 - 2) Explicar o manejo a ser feito pelo paciente/família no domicílio;
 - 3) Prazo para retorno;
 - 4) Sinais de alarme que indicam evolução desfavorável, com necessidade de reavaliação antes do prazo.
- b) Consultas de retorno, se indicado, com reavaliação do quadro clínico e manejo conforme o risco identificado nesta nova avaliação.

O uso dos testes rápidos de antígenos (p.ex., para Covid-19 ou influenza) depende da situação epidemiológica e da disponibilidade dos exames.

O registro utilizando o método SOAP ajuda a organizar o raciocínio clínico e a registrá-lo de modo a documentar o atendimento e facilitar reavaliações futuras. O Quadro 1 a seguir resume o que deve ser observado nesse processo e como registrar utilizando o método SOAP.

Quadro 1: Avaliação e registro da linha do cuidado dos quadros respiratórios agudos, por meio do SOAP

SOAP	O QUE OBSERVAR	COMO REGISTRAR
SUBJETIVO	- Sintomas predominantemente de vias aéreas superiores: coriza, obstrução nasal, dor de garganta, tosse; - Sintomas de vias aéreas inferiores: tosse proveniente de vias aéreas inferiores, sibilância; - Sintomas sistêmicos: febre, cansaço, anorexia, dor no corpo; - Sinais de alarme: idade < 3 meses, relato de febre, vomita tudo o que come, recusa do peito ou da alimentação, prostração mesmo sem febre, convulsão nas últimas 72 horas, esforço respiratório (tiragem ou batimento de asa de nariz), gemência ou estridor, cianose; - Fatores de risco para pior evolução: vacinação incompleta, história de asma ou de atopia, prematuridade, cardiopatias, internações prévias por quadro respiratório, síndromes genéticas ou de infecção congênita e tórax silencioso na ausculta.	- Descrever a evolução temporal dos sintomas. - Caracterizar brevemente os sintomas mais importantes. - Deixar claro os momentos distintos na evolução: pródromos, quadro inicial, momento em que piorou (se ocorreu piora), sintomas residuais. - Documentar os fatores de risco e suas particularidades (p.ex., na asma, o grau de controle e o tempo sem crises)
OBJETIVO	- Estado geral e sinais vitais; - Sinais de esforço respiratório; - Oroscoopia/otoscopia, se indicados pela história; - Ausculta cardíaca e pulmonar; - Teste de antígeno, se indicado.	- Documentar achados do exame físico; - Documentar testes de antígenos, se realizados.

AVALIAÇÃO	IVAS/SG SEM SINAIS DE GRAVIDADE (CID-10: resfriado comum J00, influenza J11, covid-19 B34.2): - Sintomas de vias aéreas superiores: coriza/ obstrução nasal, tosse, dor de garganta; - Ausência de sintomas de vias aéreas inferiores; - Com ou sem sintomas sistêmicos: febre, dor no corpo; - Sem alteração de frequência respiratória. BRONQUIOLITE (CID-10: J21): ≤ 2 anos (80% no 1º ano de vida); - Quadro de IVAS (tosse leve e congestão nasal) evoluindo com sibilância e taquidispneia; - Primeiro episódio de sibilância. BRONCOESPASMO/ASMA (CID-10: J45): - Tosse com sibilos em criança > 2 anos ou , se menor, com episódios recorrentes. PNEUMONIA ADQUIRIDA NA COMUNIDADE (CID-10: J15.9): - Tosse; - Febre; - Frequência respiratória aumentada, após tratamento de febre e sibilância, se presentes: 0 a 2 meses: ≥ 60 ipm 2 a 12 meses: ≥ 50 ipm 1 a 5 anos: ≥ 40 ipm
PLANO	- Orientar sobre o diagnóstico; - Se indicação de internação: - Solicitar vaga zero; - Manejo dos sinais de alarme enquanto aguarda ambulância: avaliar uso de oxigênio (mínimo 3L/min), se saturação <93%, antitérmico em caso de febre, primeira dose de antibiótico em caso de pneumonia. - Se acompanhamento ambulatorial: - Sintomáticos: soro nasal fisiológico, dipirona/paracetamol, estimular aleitamento e/ou ingesta hídrica, quando apropriado; - Antibiótico: usar apenas se pneumonia, conforme fluxograma, ou outra infecção bacteriana; - Antiviral: atentar às indicações; - Broncodilatador: usar se broncoespasmo; - Orientar sobre etiqueta respiratória;

	• Orientar sobre afastamento das atividades; • Rede de segurança: descrever evolução positiva esperada, prazo para reavaliação em caso de evolução positiva, o que pode dar errado, como identificar se o curso não foi o esperado e critérios para reavaliação antes do prazo estipulado. - Entrega do “Cartão de Acompanhamento da Criança de 0 a 5 anos com Tosse ou Dificuldade Respiratória”
--	---

4- FLUXOGRAMAS PARA A AVALIAÇÃO E O MANEJO DOS QUADROS RESPIRATÓRIOS AGUDOS EM CRIANÇAS

Com o objetivo de destacar o processo de avaliação clínica, classificação e encaminhamento dos casos de IRA em crianças, a Secretaria Municipal de Saúde organizou um fluxograma que resume o processo inicial de avaliação de todos os quadros respiratórios agudos de crianças com idade até 5 anos (Anexo 1), destacando as ações esperadas de cada categoria profissional. Esse fluxograma encerra com a classificação síndrome em grupos de manejo diferenciado.

Foram elaborados também fluxogramas específicos para a abordagem de bronquiolite viral aguda (Anexo 2), asma/broncoespasmo (Anexo 3) e pneumonia bacteriana (Anexo 4).

5- MANEJO FARMACOLÓGICO RELACIONADO AOS FLUXOGRAMAS

O Quadro 2 apresenta a posologia para a prescrição de analgésicos/antitérmicos, que podem ser prescritos por médicos e enfermeiros.

Quadro 2. Antitérmicos

Medicamento	Faixa Etária	Posologia
Dipirona 500mg/ml	a partir de 3 meses	1 gota/2 kg/dose a cada 6 ou 4 horas
Paracetamol 200mg/ml	a partir de 2 anos ou 11 kg	1 gota/kg/dose até a dosagem máxima de 35 gotas.

O Oseltamivir pode ser prescrito para toda criança com menos de 5 anos que tem suspeita de infecção por influenza. Contudo, a indicação é maior naquelas menores de 2 anos (em especial abaixo de 6 meses), ou com pneumopatias (incluindo asma), cardiopatias, doenças hematológicas, distúrbios metabólicos,

transtornos neurológicos que podem comprometer a função respiratória ou aumentar o risco de aspiração ou imunossupressão. O Quadro 3 apresenta a posologia do Oseltamivir para quem tiver indicação. A prescrição pode ser feita por médicos e/ou enfermeiros.

Quadro 3. Posologia do Oseltamivir, segundo faixa etária e peso.

Medicamento	Faixa etária		Posologia
Fosfato de Oseltamivir	Neonatos (0 a 28 dias)	IG < 38 semanas	1 mg/Kg/dose 12/12 h, 5 dias
		IG 38 a 40 semanas	1,5 mg/Kg/dose 12/12 h, 5 dias
		IG > 40 semanas	3 mg/Kg/dose 12/12 h, 5 dias
	Criança menor de 1 ano de idade	1 a 8 meses	3 mg/Kg/dose 12/12 h, 5 dias
		9 a 11 meses	3,5 mg/Kg/dose 12/12 h, 5 dias
	Criança maior de 1 ano de idade	menor ou igual a 15 Kg	30 mg 12/12 h, 5 dias
		entre 15 a 23 Kg	45 mg 12/12 h, 5 dias
		entre 23 a 40 Kg	60 mg 12/12 h, 5 dias
		maior que 40 Kg	75 mg 12/12 h, 5 dias

Observação: iniciar o Oseltamivir SOMENTE até 48 horas após início de sintomas. Não há evidências para o uso da medicação após esse período em pacientes ambulatoriais.

O antibiótico preferencial para o manejo da pneumonia adquirida na comunidade é a amoxicilina. Não há indicação de uso rotineiro da amoxicilina com clavulanato para toda criança com pneumonia. Em crianças com alergia à amoxicilina, o antibiótico preferencial é a azitromicina. As doses estão listadas no Quadro 4. Quando o paciente não tolera medicamento oral e será transferido por vaga zero, o antibiótico preferencial a ser prescrito é a ceftriaxona intramuscular (Quadro 5).

Quadro 4. Doses para administração oral de Amoxicilina ou Azitromicina (para os alérgicos) para o tratamento ambulatorial de pneumonia.

Peso em kg	Amoxicilina 250 mg por 5 mL (50 mg/ml) - posologia de 50 mg/kg/dia de 8 em 8 horas - dose máxima de 4 g/dia	Azitromicina 200 mg por 5 mL (40 mg/ml) - posologia de 10 mg/kg/dia em dose única - dose máxima de 1500 mg/dia
04 - 06	1,5 - 2 ml	1 - 1,5 ml
06 - 08	2 - 2,5 ml	1,5 - 2 ml
08 - 10	3 - 3,5 ml	2 - 2,5 ml
10 - 12	3,5 - 4 ml	2,5 - 3 ml
12 - 14	4 - 4,5 ml	3 - 3,5 ml
14 - 16	5 - 5,5 ml	3,5 - 4 ml
16 - 18	5,5 - 6 ml	4 - 4,5 ml
18 - 20	6 - 6,5 ml	4,5 - 5 ml
20 - 22	7 - 7,5 ml	5 - 5,5 ml
22 - 24	7,5 - 8 ml	5,5 - 6 ml

Quadro 5. Dose para a administração IM de Ceftriaxona para os que aguardam vaga zero e são impossibilitados de realizar dose oral do antibiótico.

Peso em Kg	Ceftriaxona IM (dose de 100 mg/kg)
04 - 06	400 - 600 mg
06 - 08	600 - 800 mg
08 - 10	800 - 1000 mg
10 - 14	1000 - 1400 mg
14 - 20	1400 - 2000 mg

Obs: a dose máxima da ceftriaxona é de 2000 mg.

6- FERRAMENTAS DISPONÍVEIS PARA APOIO NA TOMADA DE DECISÃO NO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS COM QUADROS RESPIRATÓRIOS AGUDOS

Os profissionais têm à disposição o “Cartão de Acompanhamento da Criança de 0 a 5 anos com Tosse ou Dificuldade Respiratória”, que sistematiza a coleta de dados relevantes para a tomada de decisão e para o

acompanhamento desses quadros tanto na atenção primária quanto nos serviços de urgência/emergência. Ele deve ser entregue à família, para uso em todos os atendimentos relacionados ao caso atual, e contém orientações sobre prescrições, sinais de alarme e condutas que o paciente deve tomar conforme a evolução do quadro.

Foi lançada também a ferramenta digital “Protocolo Interativo: SRA Pediátrica”, no site do Núcleo de Inteligência Assistencial da Superintendência de Atenção Primária, que sistematiza a coleta de dados clínicos e facilita a tomada de decisão a partir dos protocolos clínicos da SMS-Rio. Ele permite, ao final, copiar e colar o registro SOAP para o prontuário eletrônico. Importante destacar que o uso dessa ferramenta não substitui a avaliação clínica profissional, e a proposta final de registro SOAP deve ser revisada antes de ser inserida no prontuário. Ela pode ser acessada em: <https://niaaps.rio.br/protocolos/sra-pediatica>.

Além disso, o “Monitor Carioquinha”, desenvolvido pelo Centro de Inteligência Epidemiológica da SMS-Rio, consolida-se como ferramenta estratégica para o acompanhamento de crianças que buscaram atendimento em serviços de urgência e emergência devido a quadros respiratórios agudos. Com dados atualizados diariamente e alertas de risco infantil, o monitor auxilia diretamente no cuidado continuado na atenção primária. É destinado a todos profissionais da rede de cuidados à criança, auxiliando no suporte técnico e gerencial. Está disponível na Plataforma Subpav (<https://subpav.org/carioquinha/>).

7- VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA

A vacinação contra Influenza é recomendada para proteção dos grupos mais vulneráveis, evitando complicações como pneumonia, hospitalização e desfecho óbito.

A vacina influenza trivalente é uma suspensão injetável composta por diferentes cepas do vírus Myxovirus influenza inativados, fragmentados e purificados. Para 2026, as cepas preconizadas, conforme Instrução ANVISA, são:

- A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09.
- A/Singapore/GP20238/2024 (H3N2).
- B/Austria/1359417/2021 (B/linhagem Victoria).

Os grupos prioritários para vacinação são: crianças de 06 meses a 05 anos, 11 meses e 29 dias, gestantes em qualquer idade gestacional, idosos com 60 anos e mais.

Outros grupos também possuem recomendação para vacinação:

- Puérpera (mulheres até 45 dias pós-parto)
- Trabalhadores de saúde

- Professores do ensino básico e superior das escolas públicas e privadas
- Povos indígenas e quilombolas
- População privada de liberdade e funcionários do sistema prisional
- Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas
- Profissionais das Força de segurança pública e salvamento
- Profissionais das forças armadas
- Pessoas com deficiência permanente
- Caminhoneiros de transporte de cargas
- Trabalhadores Portuários
- Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário urbano e de longo curso
- População em situação de Rua
- Trabalhadores dos correios
- Pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e condições clínicas especiais

A vacinação é indicada, de forma global, com dose anual; para crianças que serão vacinadas pela primeira vez, o esquema é de duas doses com intervalo de 30 dias.

8- PROFILAXIA DA BRONQUIOLITE CAUSADA PELO VSR

O Vírus Sincicial Respiratório (VSR) é o principal agente etiológico da bronquiolite viral aguda e de pneumonias em lactentes. A nova estratégia de prevenção na Atenção Primária foca na proteção passiva desde a gestação e profilaxia em neonatos de alto risco.

8.1- Vacinação de Gestantes contra o VSR (Abrysvo)

A vacina bivalente contra o VSR está indicada para gestantes visando a proteção dos lactentes, assegurando a passagem da imunidade da mãe para o filho logo nos primeiros meses de vida.

Público-alvo: Gestantes a partir de 28 semanas de gestação.

Posologia: Dose única intramuscular. A transferência de anticorpos maternos protege a criança no período de maior vulnerabilidade à bronquiolite grave.

As equipes de saúde da família devem realizar a busca ativa das gestantes no pré-natal, adequando a vacinação no outono. O Monitor da Gestante Carioca pode ser usado para monitorar a cobertura vacinal das gestantes de cada equipe.

8.2- Profilaxia da Bronquiolite com os anticorpos monoclonais

Na sazonalidade de 2026 foram disponibilizados dois anticorpos monoclonais para a profilaxia da infecção pelo VSR, visto se tratar de período de transição entre essas duas tecnologias. São eles:

- I. **Palivizumabe:** é um anticorpo monoclonal específico para a prevenção da infecção grave pelo VSR, administrado nos meses de maior circulação viral (fevereiro a julho), em até 5 doses consecutivas. É disponibilizado em polos específicos, **somente para casos que tenham a reativação de cadastro pela SES.**

Indicado para as crianças prematuras nascidas com idade gestacional ≤ 28 semanas (até 28 semanas e 6 dias), com idade inferior a 1 ano (até 11 meses e 29 dias) e que tiveram aplicação de Palivizumabe na sazonalidade de 2025; e crianças com idade ≤ 2 anos portadoras de doença pulmonar crônica da prematuridade ou cardiopatia congênita com repercussão hemodinâmica demonstrada em Ecocardiograma, que realizaram a reativação do cadastro pela SES.

- II. **Nirsevimabe:** é um anticorpo monoclonal específico para a prevenção da infecção pelo VSR, indicado para crianças prematuras (≤ 36 semanas e 6 dias) com idade inferior a 6 meses (5 meses e 29 dias) e crianças com comorbidades, com idade inferior a 24 meses (até 1 ano, 11 meses e 29 dias), que apresentam maior risco de evolução para formas graves da doença. É administrado em uma dose única na temporada, definida de acordo com a faixa de peso da criança.

As comorbidades são: Doença cardíaca congênita hemodinamicamente significativa (DCC); Doença pulmonar crônica da prematuridade (DPCP); Imunocomprometimento grave - inato ou adquirido; Fibrose cística; Doença neuromuscular; Anomalias congênitas das vias aéreas; Síndrome de Down.

QUADRO 6 – Diretrizes para uso do Palivizumabe e transição do Palivizumabe para o Nirsevimabe em 2026

Grupo	Público-alvo	Conduta	Observações importantes
Grupo 1	Prematuros (≤ 28 semanas e 6 dias) com idade inferior a 1 ano (até 11 meses e 29 dias), mas que receberam Palivizumabe na sazonalidade de 2025.	Aplicar Palivizumabe na sazonalidade 2026.	-

Grupo 2	Crianças com idade inferior a 24 meses (até 1 ano, 11 meses e 29 dias), que receberam Palivizumabe na sazonalidade de 2025, com: doença pulmonar crônica da prematuridade (displasia broncopulmonar); ou doença cardíaca congênita com repercussão hemodinâmica demonstrada.	Aplicar Palivizumabe na sazonalidade 2026.	Diante da indisponibilidade de Palivizumabe, aplicar Nirsevimabe. Uma vez iniciado o Palivizumabe, deve-se finalizar o esquema de cinco doses com o mesmo medicamento, NÃO SENDO PERMITIDA A INTERCAMBIALIDADE PARA NIRSEVIMABE DURANTE A MESMA SAZONALIDADE.
Grupo 3	Crianças contempladas pelo protocolo de uso do Palivizumabe, nascidas após o término da sazonalidade de 2025 e até o final de janeiro de 2026.	Aplicar Nirsevimabe na sazonalidade 2026.	-

Fonte: CGICI/DPNI/SVSA/MS e CGAFME/DAF/SCTICEIS/MS, 2025.

9- ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA O ATENDIMENTO DOS QUADROS RESPIRATÓRIOS AGUDOS EM CRIANÇAS

É necessário assegurar o treinamento adequado de todos os profissionais para a correta identificação, avaliação e manejo dos quadros respiratórios agudos em crianças, bem como organizar os fluxos. Todo paciente com sintomas respiratórios agudos que entra na unidade de saúde e não estiver usando máscara deve receber uma. O agente comunitário de saúde e o profissional que atua no Posso Ajudar têm papel importante nessa identificação, devendo encaminhar para a sala de observação aquelas crianças que apresentarem sinais de alarme da escuta inicial.

O técnico de enfermagem deve estar treinado para a correta aferição dos sinais vitais, incluindo temperatura axilar, frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação e identificação de sinais de esforço

respiratório. Caso haja alterações importantes dos sinais vitais, deve-se chamar imediatamente um médico ou enfermeiro para confirmação.

Os pacientes com sintomas respiratórios devem idealmente se manter afastados dos demais pacientes.

É de responsabilidade do gerente da unidade assegurar que todos os profissionais estejam treinados para suas atribuições, bem como monitorar o abastecimento dos insumos e medicamentos e informar à CAP em caso de desabastecimento. Deve também estabelecer os fluxos de navegação do paciente na unidade e as responsabilidades de cada profissional.

10- ORIENTAÇÕES ACERCA DO PERÍODO DE ISOLAMENTO RECOMENDADO PARA OS CASOS SÍNDROME GRIPAL (SG) E SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG)

Com base na Nota Técnica Nº 5/2026-CGCOVID/DEDT/SVSA/MS, o isolamento passou a ser padronizado pelo diagnóstico sindrômico (independentemente da etiologia viral), simplificando a orientação: Síndrome Gripal (SG) na comunidade (Não Imunossuprimidos): Isolamento de 5 dias contados a partir do início dos sintomas. A suspensão pode ocorrer após o 5º dia, desde que o paciente esteja sem febre há 24 horas (sem antitérmicos) e apresente remissão dos sintomas. SG em Imunocomprometidos: Isolamento de 10 dias. Medidas Adicionais: Recomenda-se o uso continuado de máscara bem ajustada (PFF2/N95) até o 10º dia (ou 20º dia para imunossuprimidos).

As recomendações do Ministério da Saúde, com base em revisão da literatura, avaliação da Câmara Técnica de Assessoramento e pactuação Tripartite, passam a ser as seguintes:

Quadro 7 - Atualização das recomendações para isolamento - NT Nº 5/2026-CGCOVID/DEDT/SVSA/MS

Apresentação clínica	Recomendação
Síndrome Gripal (SG) na comunidade, independentemente da etiologia viral e não imunossuprimidos:	5 dias contados a partir da data de início de sintomas, desde que o indivíduo esteja sem febre há pelo menos 24 horas (sem uso de antitérmicos) e apresente remissão dos sintomas respiratórios.
Assintomáticos na comunidade com confirmação laboratorial de infecção pelo SARS-CoV-2 , por exame de biologia molecular (RT-PCR) ou teste rápido (TR-AG)	5 dias contados a partir da data de realização do exame.
Síndrome da Gripal (SG) independentemente da etiologia na comunidade, viral, em indivíduos imunocomprometidos :	10 dias contados a partir da data de início dos sintomas, desde que esteja sem febre há pelo menos 48 horas (sem uso de antitérmicos) e apresente remissão dos sintomas respiratórios.
Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por SARSCoV-2	20 dias contados a partir da data de início dos sintomas, desde que esteja sem febre há pelo menos 24 horas (sem uso de antitérmicos) e apresente remissão dos sintomas respiratórios.

Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por outros vírus respiratórios:

Para pacientes hospitalizados com SRAG por outros vírus respiratórios, o tempo de isolamento pode ser definido individualmente conforme o quadro clínico e identificação do agente etiológico.

Isolamento : O isolamento é a separação de indivíduos infectados dos não infectados durante o período de transmissibilidade da doença, quando é possível transmitir o patógeno em condições de infectar outra pessoa.

11- CONCEITOS GERAIS E ORIENTAÇÕES ACERCA DA NOTIFICAÇÃO E INVESTIGAÇÃO DE CASOS SÍNDROME GRIPAL (SG) E SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG)

11.1 Síndrome Gripal (SG):

Definição de caso individual: Indivíduo com infecção respiratória, com início nos últimos 10 dias, que apresente pelo menos dois dos seguintes sinais e sintomas, sendo obrigatoriamente ao menos um sintoma respiratório: Sintomas Respiratórios: Tosse, Coriza, Dor de Garganta, Congestão Nasal / Sintomas Gerais: Febre, Dor de Cabeça, Dor no Corpo, Calafrio.

Objeto de notificação individual compulsória: Síndrome Gripal suspeita de covid-19 (GM / MS nº 10.175 de 23 de janeiro de 2026)

Onde notificar: eSUS Notifica - <https://notifica.saude.gov.br/login>

Definição de surto: Ocorrência de, pelo menos, três casos de SG com vínculo epidemiológico em ambientes fechados/restritos (asilos e clínicas de repouso; creches e demais unidades escolares; unidades prisionais ou correccionais; população albergada; dormitórios coletivos; bases militares; uma mesma unidade de produção de empresa ou indústria), com intervalo de até sete dias entre as datas de início dos sintomas dos casos.

Objeto de notificação compulsória (aglomerado de casos de SG independente da etiologia): Evento de Saúde Pública (ESP) que se constitua ameaça à saúde pública (GM / MS nº 10.175 de 23 de janeiro de 2026).

Onde notificar: À Divisão de Vigilância em Saúde da sua Área Programática, conforme anexo V, durante o horário comercial (segunda a sexta-feira, das 8h às 18h). Fora desse horário (após às 18h, finais de semana e feriados), notificar ao Plantão CIEVS Rio - 21 98000-7575 / cievs.rio@gmail.com.

11.2 Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) :

Definição de caso individual: Indivíduo hospitalizado com Síndrome Gripal, que apresente pelo menos um sinal ou sintomas de agravamento: Dispneia, Taquipneia e/ou Saturação de O₂ ≤ 94% em ar ambiente.

Objeto de notificação individual compulsória: Síndrome Respiratória Aguda Grave (GM / MS nº 10.175 de 23 de janeiro de 2026)

Onde notificar: Sivep-Gripe - <https://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe/login.html?0> .

À Divisão de Vigilância em Saúde da sua Área Programática, conforme anexo V, durante o horário comercial (segunda a sexta-feira, das 8h às 18h). Fora desse horário (após às 18h, finais de semana e feriados), notificar ao Plantão CIEVS Rio - 21 98000-7575 / cievs.rio@gmail.com.

12- FORTALECIMENTO DA ARTICULAÇÃO ENTRE A APS E A VIGILÂNCIA EM SAÚDE

A APS desempenha papel estratégico na vigilância e no controle das SG, sendo fundamental sua articulação permanente com a DVS. Essa integração deve ocorrer por meio de comunicação ágil, contínua e bidirecional, permitindo a identificação precoce de casos individuais, a notificação oportuna - permitindo, assim, evitar a subnotificação e atrasos que possam comprometer a análise da situação de saúde e a tomada de decisão pelos gestores.

Nesse contexto, a APS também exerce papel fundamental na detecção de rumores de surtos, especialmente em ambientes coletivos como creches e unidades escolares, onde o risco de transmissão é ampliado. Diante dessa situação, as equipes devem comunicar à DVS, especialmente à Unidade de Resposta Rápida (URR) sobre a ocorrência do rumor e apoiar na intensificação da vigilância no território, realizando busca ativa de casos.

Além disso, é fundamental que as equipes da APS se mantenham atualizadas quanto ao cenário epidemiológico municipal e territorial, por meio do acompanhamento regular dos boletins emitidos pela respectiva Área Programática (AP), bem como dos painéis disponíveis no Observatório Epidemiológico do Rio (EpiRio — <https://epirio.svs.rio.br>), uma plataforma de acompanhamento e monitoramento epidemiológico que reúne informações atualizadas sobre a situação de saúde pública no município do Rio de Janeiro.

13- REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARSON, William J.; EDWARDS, Morven S.; BLAKE, Diane. Community-acquired pneumonia in children: outpatient treatment. In: **UpToDate**. [S.l.]: UpToDate, 2024. Disponível em: <https://www.uptodate.com/contents/community-acquired-pneumonia-in-children-outpatient-treatment>. Acesso em: 20 mar. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. **Nota Técnica nº 13/2023-CGVDI/DIMU/SVSA/MS**: orientações sobre a estratégia e operacionalização da coleta de amostras de aspirado de nasofaringe (ANF) ou swab combinado (nasal/oral) para diagnóstico laboratorial dos vírus respiratórios, no contexto da vigilância sentinela de Síndrome Gripal (SG) e da vigilância de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/covid-19/notas-tecnicas/2023/nota-tecnica-no-13-2023-cgvdi-dimu-svsa-ms/@@download/file>.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. **Nota Técnica nº 31/2026-CGICI/DPNI/SVSA/MS**: orientações técnicas simplificadas para implementação da estratégia de resgate do anticorpo monoclonal nirsevimabe no âmbito do Programa Nacional de Imunizações (PNI). Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2026. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/notas-tecnicas/2026/nota-tecnica-no-31-2026-cgici-dpni-svsa-ms.pdf>.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. **Nota Técnica nº 5/2026-CGCOVID/DEDT/SVSA/MS**: atualiza as orientações acerca do período de isolamento recomendado para os casos de Síndrome Gripal (SG) e Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), substituindo as recomendações contidas no Guia de Vigilância Integrada da covid-19, Influenza e Outros Vírus Respiratórios de Importância em Saúde Pública (2024). Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2026. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/notas-tecnicas/2026/nota-tecnica-no-5-2026-cgicovid-dedt-svsa-ms.pdf>. Acesso em: 26 mar. 2026.

CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION. CDC updates and simplifies respiratory virus recommendations. [S.l.]: CDC, 1 mar. 2024. Disponível em: <https://www.cdc.gov/media/releases/2024/p0301-respiratory-virus.htm>.

FERRONATO, Angela E.; BARREIRA, Eliane R. Bronquiolite. In: GILIO, Alfredo Elias et al. **Urgências e emergências em pediatria geral: Hospital Universitário da Universidade de São Paulo**. São Paulo: Atheneu, 2015.

GLOBAL INITIATIVE FOR ASTHMA. **Global Strategy for Asthma Management and Prevention**. [S.l.]: GINA, nov. 2025. Disponível em: <https://ginasthma.org>. Acesso em: 27 abr. 2026.

RALSTON, S. L. et al. Clinical practice guideline: the diagnosis, management, and prevention of bronchiolitis. **Pediatrics**, [S.l.], v. 134, n. 5, p. e1474-e1502, 2014.

RIO DE JANEIRO. Secretaria de Estado de Saúde. **Nota Técnica Informativa nº 01/2026-SUPAFIE/SUBAS/SES-RJ**: Programa de Profilaxia contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) - 2026. Rio de Janeiro: SES-RJ, 2026. Disponível em: https://www.rj.gov.br/saude/sites/default/files/arquivo_pagina_basica/Nota-Tecnica-Informativa-N-01-2026-SUPAFIE-SUBAS-SES-RJ.pdf.

RIO DE JANEIRO. Secretaria Municipal de Saúde. **Guia rápido de vigilância em saúde: vigilância de surtos**. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Saúde, 2025. Disponível em: https://epirio.svs.rio.br/wp-content/uploads/2025/09/Livro_VigilanciaDeSurtos2025_PDFDigital_20250929.pdf. Acesso em: 23 mar. 2026.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA (org.). **Tratado de pediatria**. 5. ed. Barueri: Manole, 2022.

ENTRADA DA CRIANÇA DE 0 A 5 ANOS NA APS COM QUADRO DE TOSSE E/OU DIFICULDADE RESPIRATÓRIA

Recepção da família ou cuidador no guichê pelo ACS. Realizar escuta inicial e ofertar atendimento.
Se a criança apresentar sinais de alerta, comunicar imediatamente ao enfermeiro ou médico e encaminhar para a sala de observação.

SINAIS DE ALERTA NA ESCUTA INICIAL PELO ACS

- Idade < 3 meses;
- Convulsão nas últimas 72 horas;
- Relato de febre;
- Relato ou observação de: vômitos, dificuldade respiratória, cansaço, recusa do peito ou da alimentação.

Encaminhar os casos com sinais de alerta da escuta inicial para a sala de observação clínica, onde o técnico de enfermagem deve iniciar avaliação dos sinais vitais e informar enfermeiro e/ou médico.
Os demais podem aguardar na sala de espera.

AVALIAÇÃO POR ENFERMEIRO OU MÉDICO (pode ser feita em consultório, na sala de observação ou em outro espaço designado)

PRAZO

Imediato: na presença de vômitos frequentes, dificuldade respiratória, cansaço, recusa do peito ou da alimentação ou prostração mesmo sem febre.

O mais breve, não ultrapassando 30 minutos: se presença de febre ou história de asma ou em menores de 3 meses.

Em até 1 hora: nos demais casos.

Considerar, quando apropriado, teste rápido de antígeno para covid-19 e/ou influenza.

HISTÓRIA		EXAME CLÍNICO		
Sintomas de vias aéreas superiores: - Coriza/obstrução nasal; - Tosse; - Estridor.	Sintomas sistêmicos: - Febre; - Cansaço; - Recusa alimentar; - Dor no corpo; - Letargia/agitação.	Sinais vitais: - Temperatura axilar; - Frequência respiratória; - Saturação; - Sinais de esforço respiratório; - Tiragem subcostal e intercostal; - Batimento de asas de nariz; - Alterações comportamentais;	- Gemência; - Recusa do peito ou de alimentos; - Letargia ou agitação.	Ausculta pulmonar: - Sibilos (avaliar se inspiratórios ou expiratórios); - Roncos.
Sintomas de vias aéreas inferiores: Tosse ou sibilos.		Sinais de baixa oxigenação: - Palidez; - Cianose; - Baixo enchimento capilar (> 2 segundos); - SatO₂ < 93.		

(*) Sinais de alarme de vaga zero imediata

- Febre em criança < 3 meses;
- Convulsões nas últimas 72 horas;
- Letárgica ou inconsciente;
- Tempo de enchimento capilar > 2s;
- Tiragem ou batimento de asa de nariz na ausência de sibilos;
- Gemência/estridor;
- Cianose.

Sinais de alarme para vaga zero imediata? (*)

SIM

VAGA ZERO (MÉDICO)

- Solicitar vaga zero, informando no encaminhamento os critérios de gravidade identificados;
- Monitorar e ofertar suporte enquanto aguarda ambulância; se broncoespasmo, administrar salbutamol 4 a 6 jatos de 20 em 20 minutos; se saturação ≤ 93%, ofertar O₂ por máscara ou cateter, com o objetivo de manter saturação entre 94 e 98%.
- Se critério para pneumonia grave (tosse, febre e frequência respiratória aumentada), administrar a primeira dose do antibiótico na unidade de atenção primária.

NÃO

Estão presentes fatores que podem comprometer a avaliação diagnóstica (Febre OU FR > OU Sibilos OU Roncos OU Sat < 93%)?

SIM

NÃO

CONSIDERAR AS SEGUINTE INTERVENÇÕES E REAVALIAÇÃO ANTES DA CLASSIFICAÇÃO SE ISSO PUDE MUDAR A CONDUTA

- Febre (aumenta frequência respiratória): antitérmico e reavaliar em 30 minutos.
ENFERMEIRO OU MÉDICO
- Roncos ou sibilos inspiratórios (dificulta a ausculta): lavagem nasal e reavaliar logo após.
ENFERMEIRO OU MÉDICO
- Sibilos expiratórios (resposta à intervenção pode ajudar a caracterizar um dos grupos diagnósticos): Iniciar broncodilatador de curta duração (salbutamol) - 4 a 6 jatos e reavaliar em 20 minutos, mantendo, se persistente, conduta conforme grupo de broncoespasmo ou bronquiolite.
PRESCRIÇÃO PELO MÉDICO. REAVALIAÇÃO POR ENFERMEIRO OU MÉDICO
- Saturação < 93% (pode estar falsamente baixa): avaliar posicionamento, pilha e outros fatores que podem comprometer o funcionamento do aparelho. Se confirmar a saturação < 93%, ofertar oxigênio (pelo menos 3L/min), com objetivo de manter a saturação entre 94 a 98%.
ENFERMEIRO OU MÉDICO

REAVALIAR AUSCULTA E FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA PARA A CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAR

ENFERMEIRO OU MÉDICO	MÉDICO		
IVAS/SG SEM SINAIS DE GRAVIDADE	BRONQUIOLITE	BRONCOESPASMO/ ASMA	PNEUMONIA ADQUIRIDA NA COMUNIDADE
- Sintomas de vias aéreas superiores: coriza/obstrução nasal, tosse, dor de garganta; - Ausência de sintomas de vias aéreas inferiores; - Com ou sem sintomas sistêmicos: febre, dor no corpo; - Sem alteração de frequência respiratória. Orientações gerais. Sintomáticos. Considerar antivirais quando apropriado.	≤ 2 anos (80% no 1º ano de vida); - Quadro de IVAS (tosse leve e congestão nasal), evoluindo com sibilância e taquidispneia; - Primeiro episódio de sibilância. Ver Fluxograma de Bronquiolite	Tosse com sibilos em criança > 2 anos ou, se menor, com episódios recorrentes. Ver Fluxograma de Asma	- Tosse; - Febre; - Frequência respiratória aumentada, após tratamento de febre e sibilância, se presentes: 0 a 2 meses: ≥ 60 2 a 12 meses: ≥ 50 1 a 5 anos: ≥ 40 Ver Fluxograma de Pneumonia Adquirida na Comunidade

DIAGNÓSTICO PROVÁVEL DE BRONQUIOLITE VIRAL AGUDA

- Idade ≤ 2 anos, especialmente no primeiro ano de vida
- Quadro de IVAS (tosse leve e congestão nasal), evoluindo com sibilância e taquidispneia
- Primeiro episódio de sibilância na vida

AVALIAR

- Estado geral
- Frequência cardíaca
- Enchimento capilar
- Oximetria
- Frequência respiratória
- Ausculta pulmonar

Fatores de risco para agravamento

- Idade < 3 meses
- Prematuridade
- Internações prévias por quadro respiratório
- Cardiopatias congênitas
- Doenças respiratórias crônicas

Sinais de gravidade

- Desidratação,
- Taquipnéia ou apneia
- Desconforto respiratório mantido
- Hipoxemia ($\text{Sat O}_2 \leq 92$),
- Recusa alimentar e de ingerir líquidos

NÃO

Tem sinais de gravidade?

SIM

CLASSIFICAR COMO BRONQUIOLITE NÃO GRAVE (ausência de sinais de gravidade)

Acompanhar na unidade de APS. Orientar:

- Higiene nasal;
- Assegurar manutenção da ingesta hídrica;
- Sinais de alerta:
 - Recusa alimentar e de líquidos;
 - Aumento da frequência respiratória ou do esforço para respirar;
 - Diminuição do volume urinário, o que pode ser percebido pela redução das trocas de fralda.
- Retorno em 24 a 48 horas, ou antes se piora.

Não recomendado o uso de corticoide na bronquiolite. O $\beta 2$ -agonista também não é recomendado de forma rotineira, porém pode ser considerado seu benefício em situações específicas em que há maior risco de evolução posterior para asma (p.ex., atopia ou história familiar positiva). Se for utilizado, a posologia do salbutamol é de 4 a 6 jatos/dose, com espaçador.

CLASSIFICAR COMO BRONQUIOLITE GRAVE *

Conduta:

- Solicitar **vaga zero**;
- Condutas enquanto aguarda ambulância:
 - Higiene/desobstrução nasal;
 - Suporte hídrico se sinais de desidratação;
 - Se frequência respiratória muito aumentada (> 70 se < 2 meses; > 60 entre 2 e 12 meses; > 50 entre 12 e 24 meses), considerar hidratação EV;
 - Considerar teste terapêutico com $\beta 2$ -agonista em aerossol dosimetrado (4 a 6 jatos de salbutamol com espaçador de 20 em 20 minutos na primeira hora);
 - Suporte de O_2 se $\text{sat O}_2 \leq 92\%$.

Para casos com sinais de gravidade limítrofes, considerar na decisão sobre a solicitação de vaga zero a presença de fatores de risco, a possibilidade de monitoramento ambulatorial, a vulnerabilidade social e a melhora clínica com a administração das intervenções listadas acima.

Reavaliação

Melhora clínica

Sem melhora

Piora

Reforçar orientações

Reavaliar em 24 a 48 horas

Piora clínica devido ao agravamento do esforço respiratório

Piora clínica devido a complicações manejáveis na APS (p.ex., otite média aguda)

Manejo clínico específico

Orientações gerais e reforçar medidas de prevenção

Melhora

Sem melhora ou com piora

DIAGNÓSTICO DE BRONCOESPASMO /ASMA

Tosse com sibilos em criança > 2 anos ou,
se menor, com episódios recorrentes.

SINAIS CLÍNICOS DE GRAVIDADE

- Alteração de consciência (confuso/torporoso)
- Saturação de O₂ < 92%;
- Fala apenas palavras ou não consegue falar ou beber;
- FC > 180bpm (0 a 3 anos) ou >150bpm (4 a 5 anos);
- FR > 40ipm;
- Cianose central;
- Tórax silencioso à ausculta;
- Não consegue falar.

NÃO

Apresenta sinais
clínicos de gravidade?

SIM

LEVE – MODERADA

- Iniciar o tratamento:
 - Salbutamol spray dosimetrado – 4 a 6 jatos de 20/20 minutos na primeira hora, com espaçador;
 - Oferta de O₂ (pelo menos 3L/min) se saturação < 93% por máscara ou cateter, com o objetivo de manter saturação entre 94 e 98%.

Reavaliação
após 1 a 2 horas

MELHORA CLÍNICA

SEM MELHORA

COM SINAIS CLÍNICOS DE GRAVIDADE

- Tratamento ambulatorial:
 - Orientar técnica inalatória;
 - Salbutamol spray dosimetrado – 4 a 6 jatos de 4/4h no primeiro dia e aumentando o intervalo progressivamente, com espaçador, por 5 dias;
 - Considerar: Prednisolona 1mg/kg (máximo de 20mg para menores de 2 anos e máximo de 30mg para idade entre 2 a 5 anos) por 3 a 5 dias;
 - Reavaliação em 24 a 48 horas.

- Tratamento ambulatorial:
 - Salbutamol spray dosimetrado – 4 a 6 jatos de h/h, com espaçador;
 - Prednisolona 1 a 2mg/kg (máximo de 20mg para menores de 2 anos e máximo de 30mg para idade entre 2 a 5 anos).

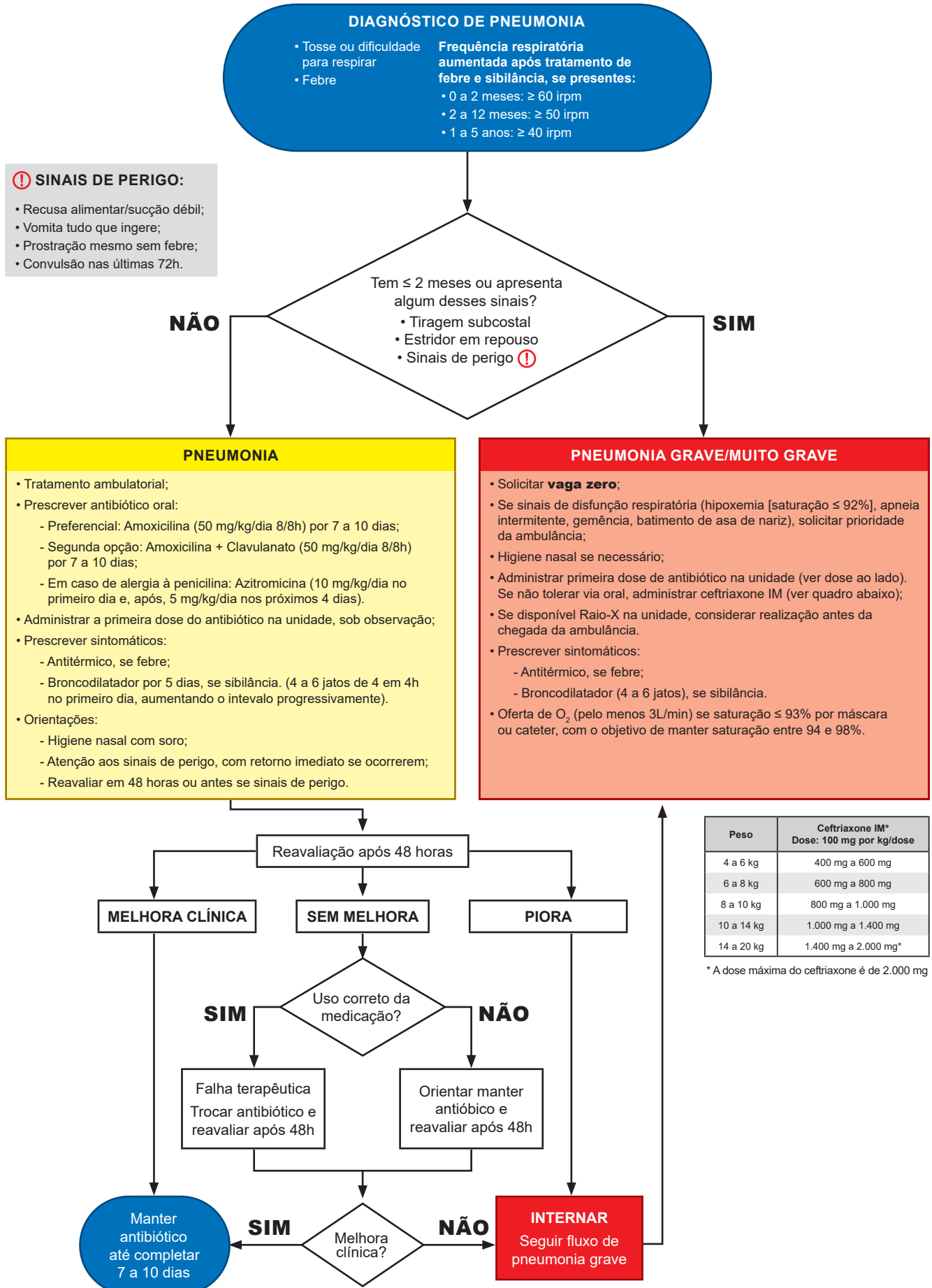
GRAVE OU RISCO DE VIDA

- Solicitar **vaga zero**;
- Iniciar:
 - Salbutamol spray dosimetrado - 6 jatos de 20/20 minutos na primeira hora, com espaçador;
 - Oferta de O₂ (pelo menos 3L/min) se saturação < 93% por máscara ou cateter, com o objetivo de manter saturação entre 94 e 98%;
 - Prednisolona 1 a 2mg/kg (máximo de 20mg para menores de 2 anos e máximo de 30mg para idade entre 2 a 5 anos).

MELHORA

Reavaliação
após 3 a 4 horas

**PIORA OU SEM RESPOSTA APÓS
TOTAL DE 10 JATOS DE SALBUTAMOL**



ANEXO V:

Lista de contatos das Divisões de Vigilância em Saúde - Município do Rio de Janeiro

AP	Endereço	E-mail
1.0	R. Evaristo da Veiga, 16 - Centro	dvscap10@gmail.com
2.1	Av. Venceslau Brás, 65 - Botafogo	vigepidemio.cap21@gmail.com
2.2	Rua Conde de Bonfim, 764 - Tijuca	dvscap22@gmail.com
3.1	Rua São Godofredo, 59 - Penha	vigepidemio.cap31@gmail.com
3.2	Rua Aquidabã, 1037 - Lins de Vasconcelos	dvscap32@gmail.com
3.3	Rua Manoel Martins, 53 - Madureira	dvscap33@gmail.com
4.0	Av. Ayrton Senna, 2001 Bloco C - Barra da Tijuca	dvs.cap40@gmail.com
5.1	Av. Carlos Pontes s/n - Sulacap	dvscap51@gmail.com
5.2	Estrada do Campinho, 2889 - Campo Grande	vigilanciaemsaude52@gmail.com
5.3	Rua Álvaro Alberto, 601 - Santa Cruz	dvscap53@gmail.com